内科含诊断 + 外科 消化性溃疡 & 消化道出血 ★★★（0~4 题）

并发症

幽门梗阻（2026）

- 餐后很快腹痛、反复呕吐（隔夜酸宿食、不含胆汁）
  低钾低氯碱中毒（2024、2026）、胃型和蠕动波、振水音（2026）
- 首先禁食补液、胃减压和引流、高渗温盐水洗胃
  缓解→痉挛或水肿性为主；不缓解→瘢痕性为主→胃大部切除术（术前用抗生素，2016）

癌变

- GU-癌变率＜1%（边缘开始），DU-不癌变（2015）
- GU 患者腹痛不规律、体重↓、保守治疗＞ 8 周无效（2013）
  贫血、粪隐血可持续阳性、胃酸缺乏
- 手术 + 化疗（2013）

内科治疗
“无酸无溃疡、无 Hp 无复发”

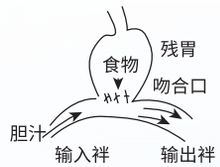
- 抑酸 —— PPI（首选 / 最佳 / 维持治疗）；P-CAB；H2-RA
- 根除 Hp —— PPI+ 铋剂 +2 种抗生素
- 保护黏膜 —— 铋剂、铝剂、米索前列醇
- 预防 NSAIDs 所致消化性溃疡：PPI+ 米索前列醇（2007、2010）

胃大部切除术（2008、2009、2010）

术后早期并发症

- 出血
- 胃瘫 —— 类似幽门梗阻但含胆汁、无胃蠕动波
  禁止手术
- 胃肠壁缺血坏死、吻合口漏或破裂
- 十二指肠残端漏或破裂

梗阻（2008、2013、2023）
出现肠绞窄（腹膜炎）→手术
否则先保守治疗、无效再手术



- 吻合口梗阻：吐出大量食物
- 输入袢梗阻
  - 急性完全性：吐出少量食物，吐后不缓解
  - 慢性不完全性：吐出大量胆汁
- 输出袢梗阻：吐出大量食物+胆汁

	食物	胆汁	其他
急性完全性输入袢梗阻	√	×	呕吐频繁、少量食物、呕吐后不缓解 闭袢性梗阻易肠绞窄
慢性不完全性输入袢梗阻	×	√	呕吐大量胆汁、进食半小时左右明显
输出袢梗阻	√	√	
吻合口梗阻	√	×	